

DIM Centros de Salud: análisis de situación y oportunidades de automatización inteligente

Diagnóstico del recorrido del paciente y de los procesos de atención, con seis propuestas concretas de mejora basadas en automatización (n8n) e inteligencia artificial aplicada.

Preparado por: Martín Fisher **Fecha:** Julio 2026 **Alcance:** análisis sobre información pública

RESUMEN EJECUTIVO

La oportunidad en una página

DIM es una institución líder de la zona oeste con más de 60 años de trayectoria, 16 centros y una apuesta digital real: app propia, portal de pacientes, WhatsApp oficial y resultados online. La base tecnológica ya existe. La oportunidad está en la **capa de orquestación**: los canales y sistemas actuales no siempre conversan entre sí, y eso genera fricciones visibles para el paciente (esperas en WhatsApp, turnos sin disponibilidad online, demoras en resultados) y costo operativo interno (call center saturado, reprocesos, reclamos).

Tesis: sin reemplazar ningún sistema existente, una capa de automatización con n8n + agentes de IA puede conectar turnero, laboratorio, WhatsApp y back-office para que cada evento (un turno liberado, un informe firmado, una receta solicitada) dispare la acción correcta sin intervención manual. Primeros resultados medibles en 30–45 días.

- **Dónde duele hoy:** acceso a turnos, tiempos de respuesta en canales digitales y comunicación proactiva con el paciente.
- **Qué propongo:** seis iniciativas priorizadas, empezando por dos quick wins de bajo riesgo (confirmación inteligente de turnos y base de conocimiento unificada).
- **Cómo lo mediría:** ausentismo, tiempo de primera respuesta, % de gestiones resueltas sin humano, reclamos públicos.

CONTEXTO

1. La institución, en números públicos

DIMENSIÓN	DATO
Trayectoria	Fundada en 1964 en Ramos Mejía por el Dr. José María Paz; hoy referente de la zona oeste (razón social DIF)
Escala	16 centros (Ramos Mejía, Morón, Liniers, Caballito, Once) · +500 profesionales · todas las especialidades, b
Servicios	Consultas, diagnóstico por imágenes, laboratorio (con extracciones a domicilio), odontología, cirugías, atenc de Oncología con el Instituto Alexander Fleming.
Financiadores	Amplia cartilla: PAMI (libre elección), IOMA, IOSFA, ASI, AMFFA y convenios institucionales, entre otros
Canales digitales	App DIM SALUD (turnos, resultados, recetas, certificados), portal.dim.com.ar con chat 24 hs, WhatsApp ofi de turnos, email.
Comunidad	~50.000 seguidores en Instagram · +70.000 en Facebook · ~19.500 en LinkedIn · Fundación DIM · sede UB

La lectura importante: DIM ya decidió ser una institución digital — su propio lema en redes es “*Te cuidamos hoy, con la tecnología del mañana*”. Este documento parte de esa decisión y propone el siguiente paso natural.

DIAGNÓSTICO

2. Fricciones detectadas en el recorrido del paciente

Relevé señales públicas (reseñas de la app, plataformas de reclamos, redes) y las ordené por etapa del recorrido. No son juicios sobre la operación interna — que seguramente tiene explicaciones y matices — sino los puntos donde el paciente hoy percibe fricción, y donde la automatización tiene más para aportar.

01 Acceso: el WhatsApp deriva, pero la cola no cierra el ciclo

El asistente virtual toma el contacto pero, según reclamos públicos reiterados, la derivación a operador queda sin respuesta durante horas. El paciente reintenta por teléfono o va a la sede: el mismo caso cuesta tres veces. Fuente: reclamos en tuQuejaSuma, 2024–2026.

02 Turnos: disponibilidad online que no refleja la capacidad real

Pacientes reportan que ciertas especialidades (ecografía, ginecología) no muestran turnos en el canal online pese a ofrecerse en varios centros, y bugs puntuales de la app al seleccionar turno. La capacidad existe; el canal no siempre la expone. Fuente: reclamos públicos y reseñas de la app.

03 Agenda: cancelaciones sin aviso y ausentismo

Hay reclamos por turnos cancelados sin notificación previa. La contracara —pacientes que no asisten— es el costo silencioso de toda agenda médica: los benchmarks del sector en Argentina ubican el ausentismo entre 20 y 30% cuando no hay confirmación activa.

04 Resultados: el paciente pregunta en lugar de ser avisado

Los resultados están 100% online (fortaleza real), pero hay reclamos por demoras y por estudios que no aparecen, con teléfonos y mensajería sin respuesta para consultarlo. Falta el eslabón proactivo: que el sistema avise cuando el informe está firmado, y que alguien vea internamente los que exceden el plazo.

05 Recetas y autorizaciones: solicitudes sin estado visible

La app permite pedir receta digital, pero existen reclamos por solicitudes sin respuesta. El paciente no tiene forma de saber si su pedido está en curso, demorado o rechazado — y cada consulta de estado vuelve a cargar el call center.

06 Información inconsistente entre canales

Reclamos mencionan información distinta según se consulte al call center, a la sede o al chat (coberturas, preparaciones de estudios, horarios). Cada canal responde con su propia fuente; no hay una base de conocimiento única que alimente a todos.

07 Reputación digital sin circuito de recuperación

Las quejas se acumulan en plataformas públicas y reseñas, muchas veces por casos que eran recuperables si alguien los detectaba a tiempo. No se observa un circuito sistemático de escucha, respuesta y recupero del paciente insatisfecho.

Patrón común: ninguna de estas fricciones es un problema de falta de sistemas —turnero, laboratorio, app y WhatsApp ya existen. Son problemas de **eventos que no viajan entre sistemas** y de **ciclos que no cierran**. Exactamente el tipo de problema que resuelve una capa de orquestación.

PRIORIZACIÓN

3. Seis iniciativas, ordenadas por impacto y esfuerzo

#	INICIATIVA	FRICCIÓN QUE ATACA	IMPACTO	ESFUERZO	HORIZONTE
P1	Confirmación inteligente de turnos + lista de espera	02 · 03	ALTO	Bajo	Semanas 3–6
P2	Base de conocimiento única (RAG) para todos los canales	06 · 01	ALTO	Bajo	Semanas 3–6
P3	Agente IA en WhatsApp con acceso real al turnero	01 · 02	ALTO	Medio	Semanas 7–10
P4	Entrega proactiva de resultados + control de SLA interno	04	ALTO	Medio	Semanas 7–10
P5	Circuito de recetas y autorizaciones con estado visible	05	MEDIO	Medio	Semanas 11–13
P6	Voz del paciente: encuestas, alertas y tablero operativo	07	MEDIO	Bajo	Semanas 11–13

Segunda ola (a validar con el equipo): automatización de back-office (validación de órdenes y autorizaciones de financiadores, digitalización de órdenes en papel, control de débitos) y onboarding automatizado de personal y profesionales — dos áreas donde ya tengo proyectos implementados.

PROPUESTAS

4. Fichas de propuesta

P1 Confirmación inteligente de turnos y lista de espera automática	
PROBLEMA	Ausentismo sin gestión activa; cancelaciones que dejan huecos muertos en agenda; pacientes cancelados sin aviso.
SOLUCIÓN	Workflow n8n conectado a la agenda: recordatorio por WhatsApp a las 48 y 24 hs con respuesta de un toque (confirmo / reprogramo / cancelo). Cada hueco liberado se ofrece automáticamente al primer paciente compatible de la lista de espera. Si un profesional cancela su agenda, todos sus pacientes reciben aviso y opciones de reprogramación en minutos.
IMPACTO	Reducciones típicas del 30–50% del ausentismo con confirmación activa; agenda más llena con la misma estructura; elimina la queja pública más sensible (cancelación sin aviso).
MEDICIÓN	Tasa de no-show, % de huecos reasignados, turnos reconfirmados por semana.

P2 Base de conocimiento única con IA (RAG) para todos los canales

PROBLEMA	Call center, sedes y chat responden distinto sobre coberturas, preparaciones de estudios y horarios.
SOLUCIÓN	Consolidar en una base única el contenido que ya existe (preparaciones, cartilla, horarios por sede, requisitos por financiador) y exponerla vía IA con recuperación de contexto: el mismo motor responde al asistente de WhatsApp, al chat del portal y a una consola interna para operadores del call center.
IMPACTO	Respuesta consistente en todos los canales; operadores nuevos productivos en días; menos llamadas repetidas por información errónea.
MEDICIÓN	Precisión de respuestas auditadas, tiempo medio de atención del call center, recontactos por el mismo motivo.

P3 Agente de IA en WhatsApp con acceso real al turnero

PROBLEMA	El asistente actual deriva a operadores que no llegan a responder; el paciente abandona el canal.
SOLUCIÓN	Agente conversacional (Claude) orquestado con n8n sobre la API de WhatsApp Business, con herramientas conectadas al turnero: consulta disponibilidad real por especialidad y sede, reserva, reprograma y cancela, informa preparaciones. Deriva a humano solo los casos que lo requieren, con cola priorizada, SLA visible y contexto completo de la conversación para el operador.
IMPACTO	Atención 24/7 real; resolución sin humano de la mayoría de las gestiones de turnos (benchmark del sector: 60–80%); descompresión inmediata del call center.
MEDICIÓN	% de gestiones resueltas sin operador, tiempo de primera respuesta, abandono de conversación, NPS del canal.

P4 Entrega proactiva de resultados y control interno de demoras

PROBLEMA	El paciente pregunta por sus resultados en lugar de ser avisado; los estudios demorados se descubren por reclamo.
SOLUCIÓN	Cuando el informe se firma en el sistema de laboratorio/imágenes, n8n notifica al paciente por WhatsApp con acceso seguro y avisa a su médico si corresponde. En paralelo, un monitor interno alerta al sector cuando un estudio supera su plazo esperado — la demora se gestiona antes de que el paciente la sufra.
IMPACTO	Menos llamadas entrantes de consulta de estado; demoras detectadas internamente en lugar de en redes; percepción de servicio moderno.
MEDICIÓN	Tiempo informe firmado → paciente notificado, estudios fuera de SLA detectados internamente vs. por reclamo.

P5 Circuito de recetas y autorizaciones con estado visible

PROBLEMA	Solicitudes de receta digital sin respuesta ni estado consultable; cada “¿cómo va mi pedido?” es una llamada más.
SOLUCIÓN	Intake estructurado (app/WhatsApp) con validación automática de datos y cobertura, ruteo al profesional correcto, recordatorios internos por SLA y notificación automática al paciente en cada cambio de estado: recibido, en revisión, emitida, rechazada con motivo.
IMPACTO	Cierra un ciclo hoy abierto; elimina una fuente completa de reclamos y llamadas.
MEDICIÓN	Tiempo de ciclo de receta, % de solicitudes vencidas de SLA, llamadas por consulta de estado.

P6 Voz del paciente: encuestas post-atención, alertas y tablero

PROBLEMA	La insatisfacción se conoce cuando ya es un reclamo público; la dirección no tiene métricas de experiencia en tiempo real.
SOLUCIÓN	Encuesta breve automática post-atención por WhatsApp; análisis de sentimiento con IA sobre respuestas y menciones; alerta inmediata al responsable cuando aparece un detractor, con el caso y su historia; tablero para dirección con NPS, ausentismo, tiempos de respuesta y volumen por canal.
IMPACTO	Casos recuperados antes de escalar a queja pública; decisiones de operación basadas en datos frescos.
MEDICIÓN	NPS por sede y servicio, % de detractores contactados en <24 hs, evolución de reclamos públicos.

5. Hoja de ruta: primeros 90 días

FASE	SEMANAS	QUÉ SE HACE	ENTREGABLE MEDIBLE
Discovery	1–2	Shadowing en call center y sedes; mapa real de sistemas (turnero, laboratorio, app, telefonía) y sus puntos de integración; línea base de métricas.	Mapa de procesos y sistemas + métricas base acordadas.
Quick wins	3–6	P1 (confirmación de turnos + lista de espera) en una sede piloto. P2 (base de conocimiento) alimentando la consola del call center.	Ausentismo del piloto vs. línea base; auditoría de consistencia de respuestas.
Escalado	7–10	P3 (agente WhatsApp) en piloto controlado con derivación a humano supervisada. P4 (resultados proactivos) para laboratorio.	% de gestiones sin operador; tiempo informe → notificación.
Consolidación	11–13	P5 (recetas) y P6 (voz del paciente + tablero). Extensión de pilotos exitosos al resto de las sedes.	Tablero operativo en uso por dirección; plan de rollout 2027.

Principios de trabajo

- **Integrar, no reemplazar:** todo se construye sobre los sistemas que DIM ya tiene, vía API y eventos. Cero migraciones forzadas.
- **Humano en el circuito:** la IA resuelve lo repetitivo y prepara el contexto; las decisiones clínicas y los casos sensibles siempre llegan a una persona.
- **Datos de salud con máximo cuidado:** cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (los datos de salud son datos sensibles), acceso mínimo necesario, trazabilidad de cada automatización.
- **Medir antes y después:** cada iniciativa arranca con línea base y se juzga por su métrica, no por la demo.

SOBRE ESTE TRABAJO

6. Quién lo propone y con qué base

Trabajo diseñando e implementando automatizaciones de procesos con **n8n** y desarrollo asistido por IA con **Claude**, con proyectos entregados que van desde chatbots conversacionales con integración a sistemas de gestión hasta circuitos completos de onboarding. Mi enfoque es el que refleja este documento: entender el proceso primero, automatizar lo que se repite, medir el resultado.

Nota metodológica: este análisis se elaboró exclusivamente con información pública (sitio y portal de DIM, tiendas de aplicaciones, plataformas de reclamos, prensa y redes sociales) entre el 6 y el 8 de julio de 2026. Los diagnósticos son hipótesis de trabajo a validar con el equipo de DIM; las cifras de benchmark corresponden al sector salud argentino y no a mediciones internas de la institución.